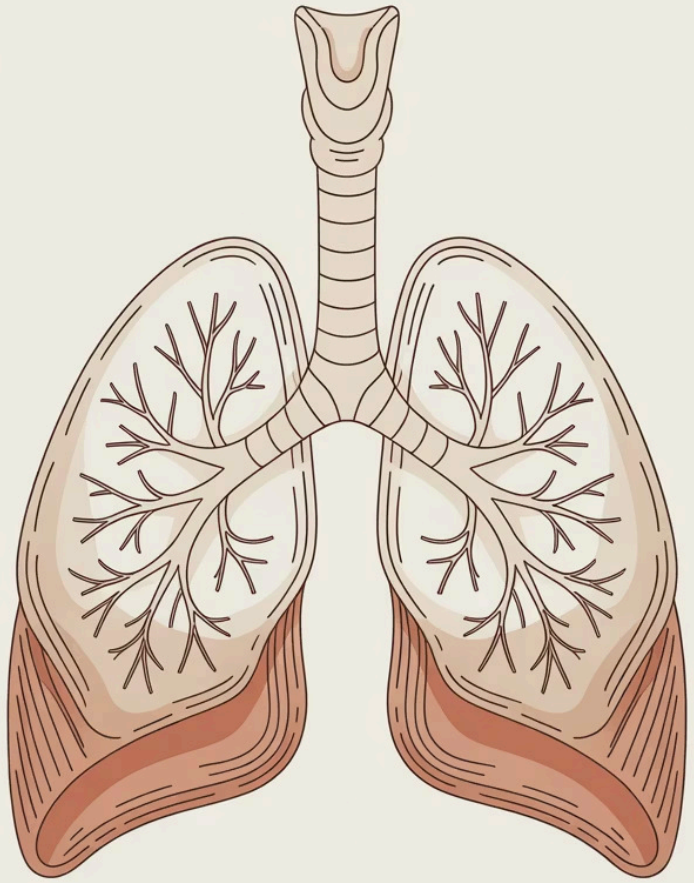
Actualización en el Abordaje de las Neumonías desde Atención Primaria

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) representa una de las principales causas de mortalidad por motivo infeccioso. Esta guía actualizada proporciona las herramientas esenciales para el diagnóstico, tratamiento y prevención desde atención primaria.



LUNG
ANATOMY

¿Qué es la Neumonía Adquirida en la Comunidad?

Definición

Lesión inflamatoria aguda del parénquima pulmonar de origen infeccioso, ocurrida fuera del hospital. Puede presentar afectación bilateral en casos graves.

Realidad Diagnóstica

Solo el 38% de pacientes hospitalizados tienen un patógeno identificado. El 40% presenta virus como causa probable y 15% Streptococcus pneumoniae.

El diagnóstico se establece de manera sindrómica, basándose en síntomas clínicos y evidencia de infiltrado pulmonar, ya que rara vez se cuenta con información histológica completa.

Epidemiología: Datos Clave

2-5

Casos por 1.000 adultos

Incidencia anual estimada

80%

Tratamiento ambulatorio

Mayoría de casos de NAC

5-10%

Requieren hospitalización

Del total de casos

20%

Cuidados intensivos

De los casos hospitalizados

La incidencia aumenta en varones, extremos de edad (< 5 y > 65 años) y presencia de comorbilidades. Los factores de riesgo más determinantes incluyen enfermedad pulmonar subyacente, tabaquismo e inmunosupresión.

Factores de Riesgo Principales

Respiratorios

- EPOC, bronquitis, asma
- Tabaquismo activo
- Historia previa de neumonía

Sistémicos

- Inmunosupresión
- Enfermedades cerebrovasculares
- Cáncer

Otros

- Disfagia
- Abuso de alcohol
- Malnutrición

Variables Epidemiológicas Clave

01

Ubicación Geográfica

Conocimiento del nicho microbiológico local. En España: S. pneumoniae principal causante, seguido de Mycoplasma y Chlamydia.

02

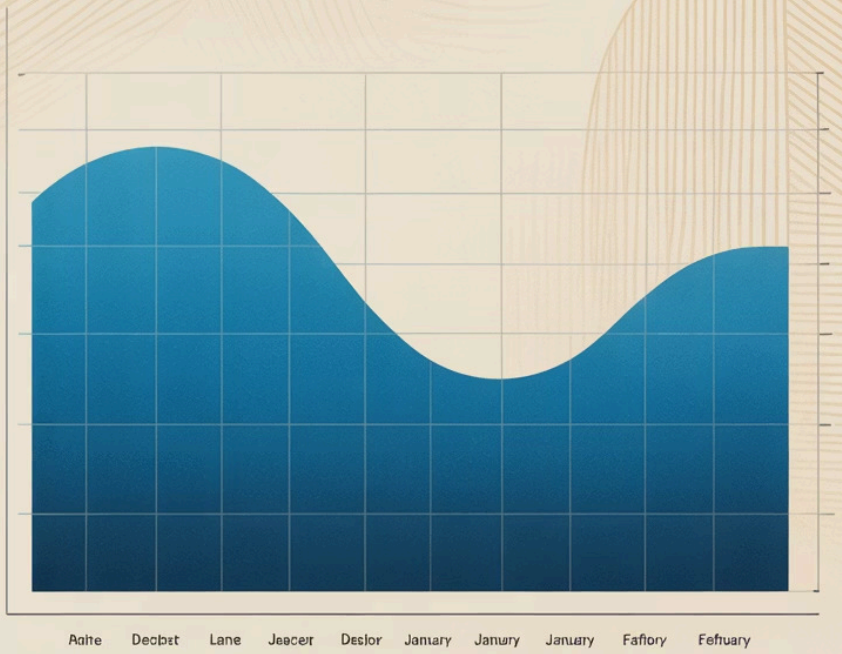
Estación del Año

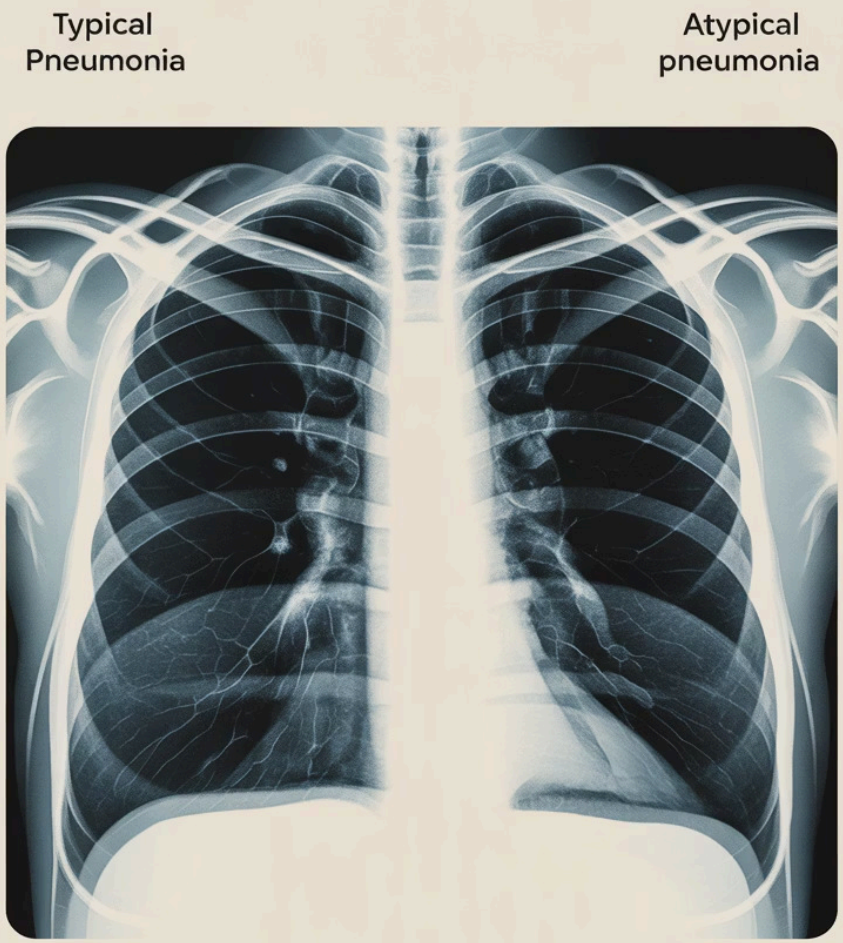
Mayor frecuencia en meses fríos, coincidiendo con temporadas de virus respiratorios.

03

Características Individuales

Edad, sexo, dependencia, estado inmunitario, comorbilidad, gravedad y exposición ambiental.





Clasificación Clínico-Radiológica

Neumonía Típica

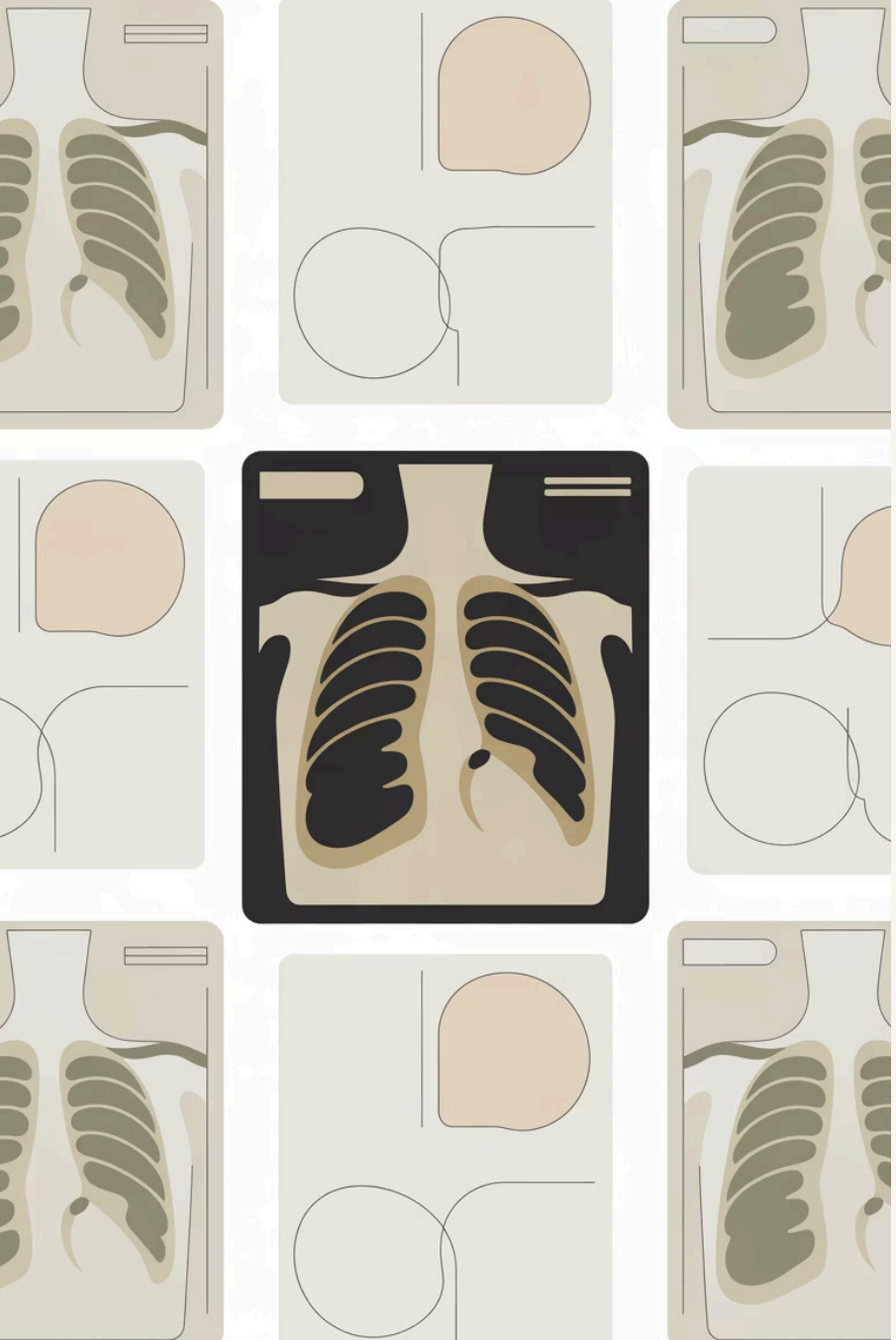
- Fiebre elevada de inicio brusco
- Tos productiva con esputo purulento
- Dolor torácico pleurítico
- Crepitantes localizados
- Leucocitosis asociada

Agente habitual: Neumococo

Neumonía Atípica

- Patocronía más larvada
- Febrícula, cefalea
- Tos seca, mialgias
- Auscultación puede ser normal
- Patrón intersticial radiológico

Agentes: Mycoplasma, Chlamydia, virus



Patrones Radiológicos de la Neumonía

1

Neumonía Alveolar o Lobar

Afecta múltiples alvéolos respetando bronquíolos. Presenta broncograma aéreo. Típica del neumococo.

2

Bronconeumonía

Compromete alvéolos y bronquíolos. Expresión segmentaria múltiple. Causada por P. aeruginosa, gramnegativos, S. aureus.

3

Neumonía Intersticial

Afecta exclusivamente intersticio. Manifestación de microorganismos atípicos: virus, C. psittaci, M. pneumoniae.

Métodos Diagnósticos: Fortalezas y Limitaciones

Radiografía de Tórax

Fortalezas: Baja radiación, accesible, económica

Limitaciones: Baja sensibilidad, infiltrados pueden estar ausentes inicialmente

Tomografía Computarizada

Fortalezas: Alta sensibilidad, evaluación de complicaciones

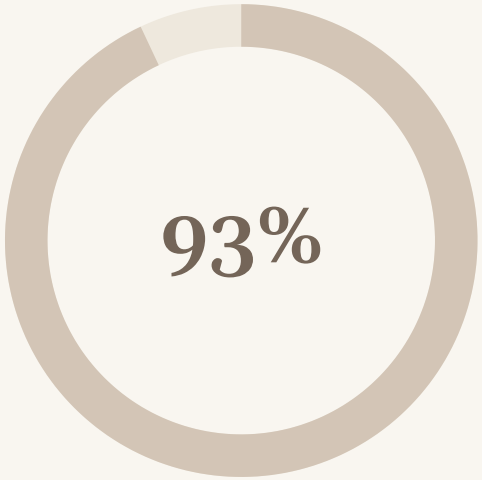
Limitaciones: Alta radiación, tiempo, coste elevado

Ecografía Pulmonar

Fortalezas: Sin radiación, portátil, evaluación dinámica

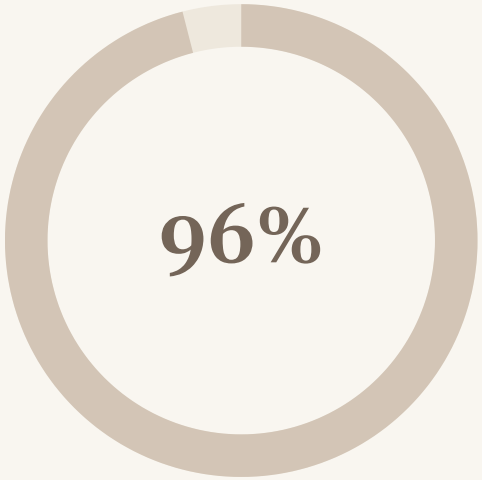
Limitaciones: Dependiente del operador, no detecta neumonías profundas

Ecografía Pulmonar: Revolución Diagnóstica



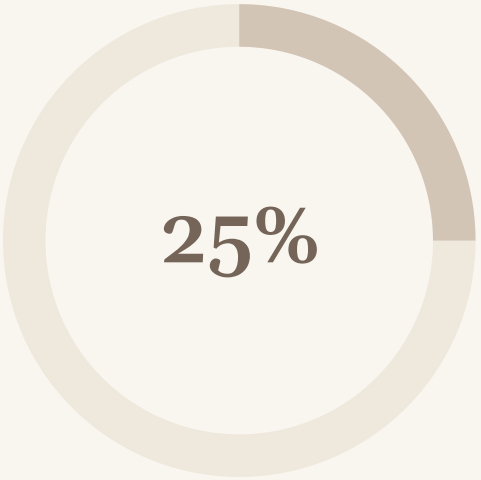
Sensibilidad

Ecografía pulmonar vs 54% radiografía



Especificidad

Precisión diagnóstica



Más casos detectados

Comparado con radiografía

La ecografía pulmonar tiene mayor sensibilidad que la radiografía de tórax, detectando hasta un 25% más de casos. Su principal limitación: solo detecta neumonías en contacto con la pleura.

Hallazgos Ecográficos Normales

Deslizamiento Pleural

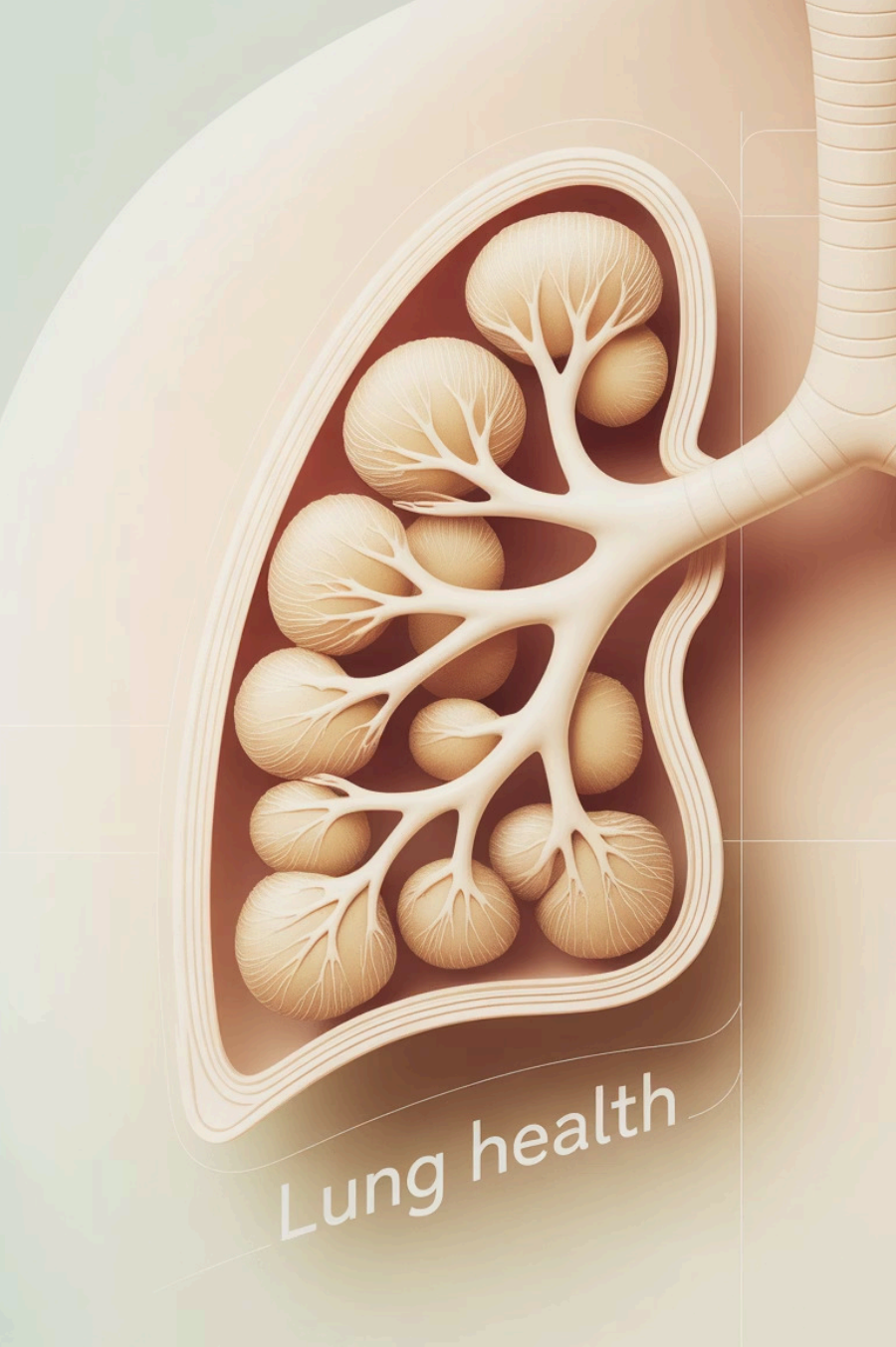
Resplandor del deslizamiento fisiológico de pleura visceral contra parietal durante respiración, visible en la línea pleural.

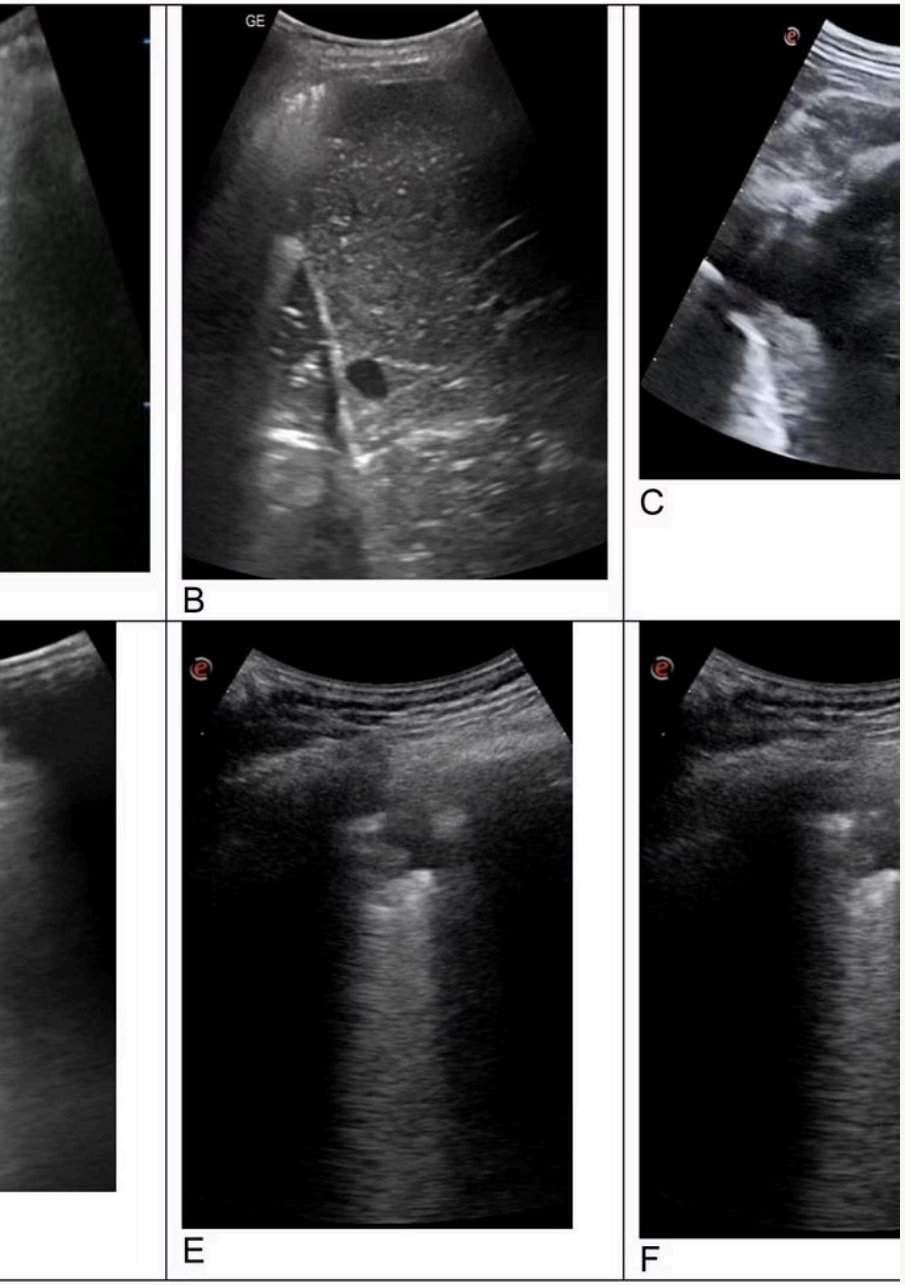
Líneas A

Líneas horizontales hiperecoicas equidistantes a línea pleural. Indican ausencia de consolidación y síndrome intersticial.

Signo de Cortina

Base pulmonar normalmente aireada que aparece como cortina borrando área subdiafragmática durante inspiración.





Hallazgos Ecográficos Patológicos

1

Irregularidades Pleurales

Engrosamiento de línea pleural y broncograma aéreo dinámico (partículas hiperecoicas móviles como hormigas en movimiento).

2

Líneas B

Tres o más líneas hiperecogénicas verticales dinámicas desde pleura. Indican engrosamiento de tabiques por acumulación de líquido.

3

Consolidación Alveolar

Pulmón hepatizado: parénquima con ecogenicidad similar al hígado cuando alvéolos se llenan de líquido o colapsan.

Diagnóstico Microbiológico

PCR

Detección de virus (COVID-19, influenza, VRS) mediante hisopo nasofaríngeo. Técnica muy sensible pero puede indicar colonización.

Antígenos en Orina

S. pneumoniae: especificidad >90%, sensibilidad 50-80%. Legionella: sensibilidad 70-90%, especificidad ~100%.

Cultivos

Recogida antes del tratamiento antibiótico. Permite identificación específica y antibiograma para tratamiento dirigido.

Tratamiento Ambulatorio en Adultos

1

Primera Línea

Amoxicilina 1g/8h durante 5-7 días. Añadir clavulánico en EPOC/asma. Alternativa: cefditoreno 400mg/12h ± azitromicina 500mg/24h x 3 días.

2

Quinolonas

Levofloxacino 750mg/24h durante 5-7 días o **moxifloxacino 400mg/24h.** Excelente cobertura neumocócica y atípicos.

3

Neumonía Atípica

Doxiciclina 100mg/12h durante 7-14 días, asegurando 24-48h libres de síntomas tras resolución clínica.

Tratamiento Pediátrico por Edades

< 3 meses

Tratamiento hospitalario obligatorio

1

2

4 meses - 4 años

Típica: Amoxicilina 80-90mg/kg/día x 7 días. Atípica: Azitromicina 10mg/kg/día x 3 días

3

> 5 años

Típica: Amoxicilina 80-90mg/kg/día x 7 días. Atípica: Azitromicina igual esquema anterior

En caso de alergia a betalactámicos tipo I: macrólidos. Sin hipersensibilidad tipo I: cefuroxima 30mg/kg/día en dos tomas durante 7 días.

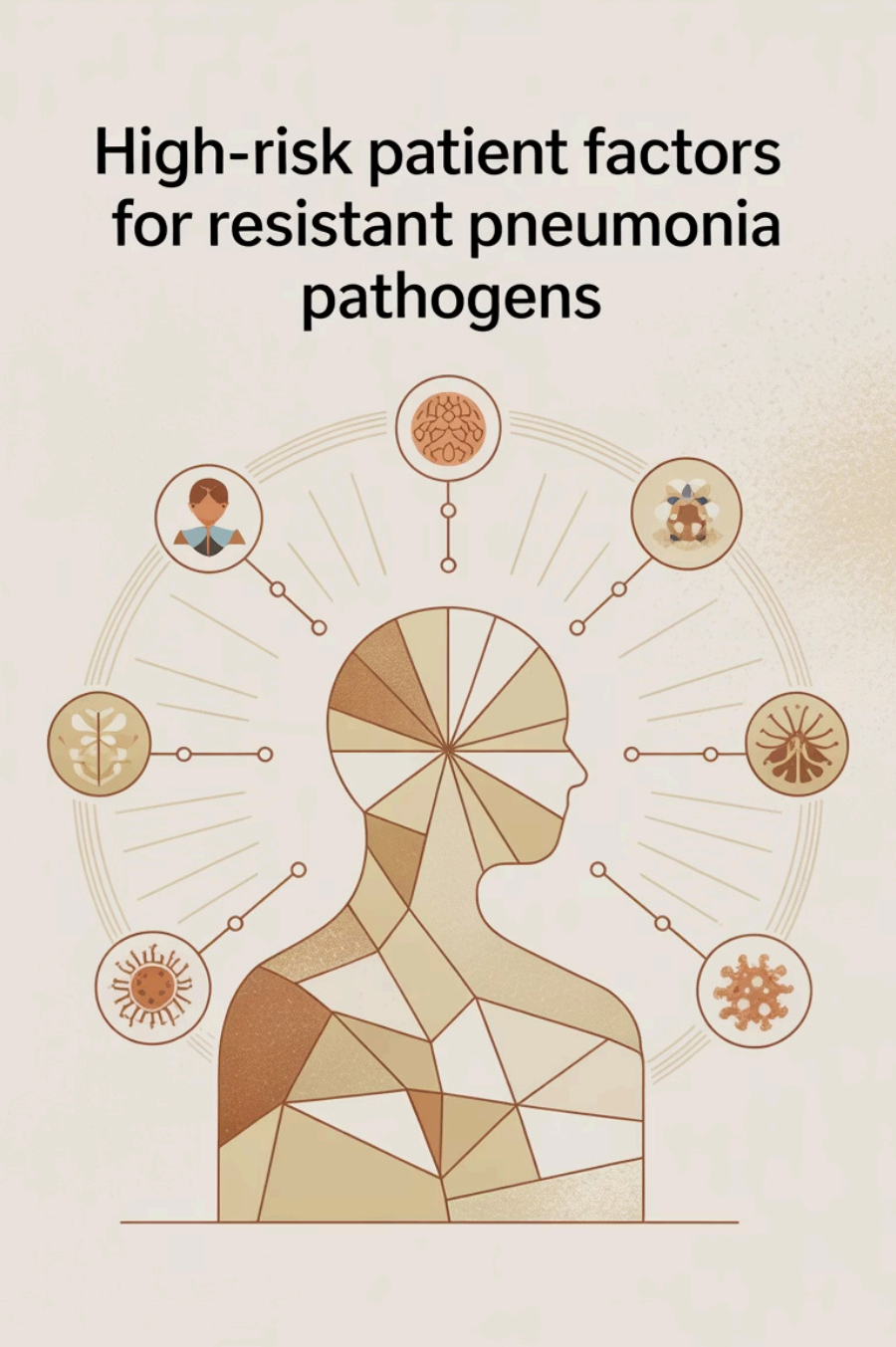
Factores de Riesgo Especiales

Staphylococcus aureus

- Infección por virus gripe
- Usuarios de drogas parenterales
- Traumatismo craneoencefálico
- Insuficiencia renal crónica
- Diabetes insulinodependiente

Pseudomonas aeruginosa

- Antibióticos previos 3-5 días
- Colonización/infección previa
- Anciano de centro geriátrico
- Traqueostomía, gastrostomía
- Sonda urinaria permanente



Prevención: Vacunación Antineumocócica

15-valente

Aprobada por EMA, esquemas flexibles 2+1 o 3+1

13-valente Conjugada

Clásica, asociada a polisacárida 23-valente

20-valente

Autorizada por FDA y EMA, protocolo 3+1 dosis

La AEP recomienda reemplazar la 13-valente por las nuevas opciones (15 o 20-valente) tanto para niños sanos como con factores de riesgo. Las vacunas se administran con varios meses de separación.

Vacunación VRS: Resultados Impresionantes

75%

Reducción Ingresos

Niños < 12 meses temporada 2023-2024

87.6%

Menos Hospitalizaciones

Por VRS en Cataluña

90.1%

Reducción UCI

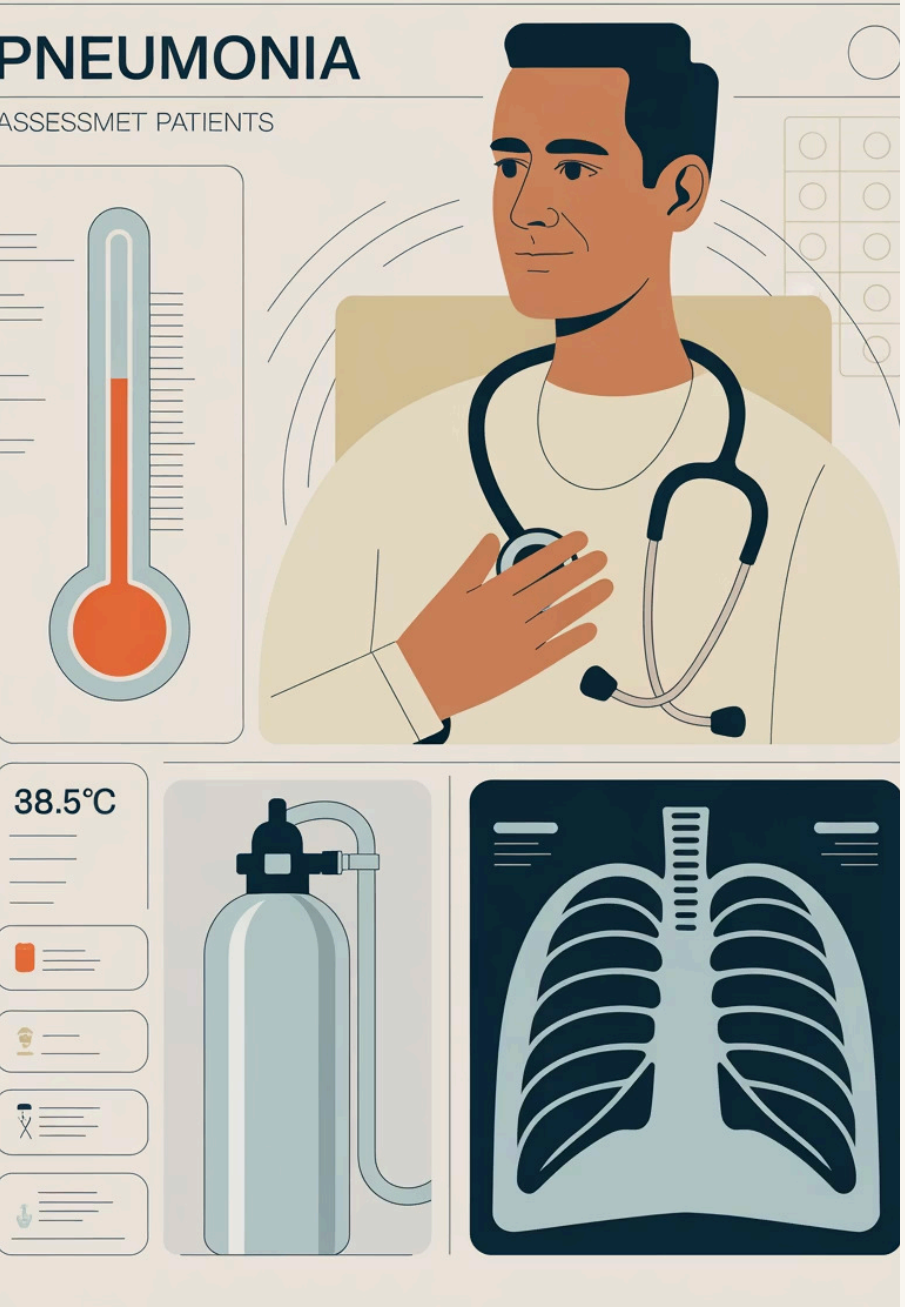
Ingresos en cuidados intensivos

48.1%

Menos Bronquiolitis

En atención primaria

Una única dosis intramuscular ofrece protección durante toda la temporada. Se evitaron aproximadamente 10.000 hospitalizaciones en España durante la primera campaña.



Escalas de Valoración Hospitalaria

Escala PSI

Pneumonia Severity Index

- Edad, sexo, residencia
- Enfermedades coexistentes
- Examen físico
- Datos laboratorio/radiología

> 70 puntos: Evaluación hospitalaria

< 70 puntos: Tratamiento ambulatorio

Escala CURB-65

- **C**onfusión mental
- **U**rea > 19 mg/dl
- **R**espiratory rate > 30
- **B**lood pressure < 90/60
- Edad > **65** años

≥ 2 puntos: Ingreso hospitalario

< 2 puntos: Tratamiento ambulatorio

Neumonías de Repetición

01

Seguimiento Post-Recuperación

Importancia del control evolutivo en atención primaria. No se recomienda control radiológico rutinario tras infección respiratoria.

02

Criterio de Derivación

Procesos recurrentes requieren estudio especializado en neumología para descartar patología subyacente.

03

Diagnóstico Diferencial

Investigar procesos oncológicos, reumatológicos o infecciosos complicados en casos de repetición.

Puntos Clave para Atención Primaria

Diagnóstico

Ecografía pulmonar superior a radiografía. Diagnóstico microbiológico antes de antibióticos. Considerar factores epidemiológicos.

Tratamiento

Inicio precoz empírico. Amoxicilina primera línea. Ajustar según edad y factores de riesgo. Duración 5-7 días.

Prevención

Vacunación antineumocócica y antigripal. Nuevas vacunas 15 y 20-valente. VRS en lactantes con excelentes resultados.

Derivación

Escalas PSI y CURB-65 para valoración hospitalaria. Seguimiento de neumonías recurrentes. Control evolutivo ambulatorio.